



Isian Substansi Proposal

SKEMA PENELITIAN DASAR (PENELITIAN DOSEN PEMULA AFFIRMASI, PENELITIAN DOSEN PEMULA, PENELITIAN PASCASARJANA)

Pengusul hanya diperkenankan mengisi di tempat yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengisian dan tidak diperkenankan melakukan modifikasi template atau penghapusan di setiap bagian.

A. JUDUL

Tuliskan judul usulan penelitian maksimal 20 kata

[Model Awal Prototipe Hibrid ROTASI: Self-Monitoring Preeklamsia Berbasis AHA 2025 mendukung SDG 3.2 dan AstaCita 7 dalam Pencegahan Stunting Pesisir]

B. RINGKASAN

Isian ringkasan penelitian tidak lebih dari 300 kata yang berisi urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetkan

[Urgensi: Preeklamsia merupakan komplikasi kehamilan ditandai dengan hipertensi maternal yang bertanggung jawab atas 11-14% dari semua kematian ibu secara global, dengan kontribusi signifikan terhadap morbiditas dan mortalitas perinatal (WHO 2023). **Preeklamsia meningkatkan risiko bayi berat lahir rendah (BBLR) yang menjadi determinan kunci stunting** (risiko 9.3 kali lebih tinggi). Prevalensi stunting nasional mencapai 19.8% (SSGI 2024), dengan tantangan lebih berat di wilayah pesisir yang menghadapi akses kesehatan maternal terbatas dan literasi kesehatan yang rendah. Deteksi dini preeklamsia melalui *self-monitoring* menjadi strategi pencegahan stunting sektor hulu yang belum optimal diterapkan. **Tujuan:** Mengembangkan **prototipe awal hibrid ROTASI** sebagai model self-monitoring preeklamsia **berbasis AHA guideline 2025**. Ibu hamil dapat melakukan deteksi dini dan manajemen preeklamsia mandiri. Prototipe ini mendukung pencegahan stunting sektor hulu serta **pencapaian SDG 3.2** (eliminasi stunting) dan **Asta Cita 7** (sumber daya manusia berkualitas). **Metode:** Penelitian *Research & Development* (R&D) dengan kerangka ADDIE untuk mengembangkan prototipe *low-fidelity* ROTASI pada TKT 2-3. Integrasi *Health Belief Model* (HBM) mendukung perilaku *self-monitoring* berkelanjutan ibu hamil. Pengembangan dilaksanakan melalui 4 fase: *literature review & FGD stakeholder* untuk identifikasi kebutuhan desain, pengembangan model awal *prototype* hibrid ROTASI, validasi ahli, dan uji kelayakan pada 15 ibu hamil di wilayah pesisir. **Luaran ditargetkan:** model awal prototipe hibrid ROTASI (fisik dan digital), dua hak kekayaan intelektual (HAKI) prototipe fisik dan digital, dan artikel publikasi SINTA 4.]

C. KATA KUNCI

Isian 5 kata kunci yang dipisahkan dengan tanda titik koma (;)

[Prototipe *self-monitoring* preeklamsia; stunting pesisir; *health belief model*; rekomendasi *AHA guideline 2025*; *maternal health innovation* SDG 3.2]

D. PENDAHULUAN

Pendahuluan penelitian tidak lebih dari 1000 kata yang terdiri dari:

- Latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti
- Pendekatan pemecahan masalah
- State of the art dan kebaruan
- Peta jalan (road map) penelitian 5 tahun

Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan.

D.1. LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH

Tuliskan latar belakang penelitian dan rumusan permasalahan yang akan diteliti, serta urgensi dari dilakukannya penelitian ini

[Latar belakang: Preeklamsia merupakan komplikasi kehamilan dengan prevalensi 5,3% atau sekitar 128.273 kasus per tahun di Indonesia,¹ dan tetap menjadi penyebab utama kematian ibu (26,9% dari semua kematian maternal nasional).² Penelitian terbaru melibatkan 30 rumah sakit di Indonesia (2022-2023) menunjukkan bahwa preeklamsia tidak hanya mengancam kehidupan ibu dengan mortalitas 1,33%, tetapi juga menghasilkan *outcomes* perinatal yang signifikan buruk: *intrauterine fetal death rate* meningkat 6,2 kali dan neonatal mortality meningkat 2,8 kali.³ Mekanisme patofisiologis preeklamsia menyebabkan gangguan perfusi utero-plasenta yang berimplikasi pada pembatasan pertumbuhan intra-uteri (*intrauterine growth restriction/IUGR*) dan kelahiran bayi berat lahir rendah (BBLR). Meta-analisis terbaru menyatakan bahwa BBLR merupakan determinan kunci stunting dengan risiko 2,3 kali lebih tinggi untuk mengalami stunting dibandingkan bayi dengan berat lahir normal.⁴ Dengan prevalensi stunting nasional Indonesia mencapai 19,8% (Survei Status Gizi Indonesia/SSGI 2024)⁵, wilayah pesisir menghadapi tantangan lebih kompleks dengan akses layanan kesehatan maternal terbatas dan literasi kesehatan rendah.⁶ Deteksi dini preeklamsia melalui *self-monitoring*⁷ berkelanjutan merepresentasikan strategi pencegahan stunting sektor hulu yang belum optimal diterapkan. Rekomendasi terbaru dari *American Heart Association (AHA) guideline 2025* mengidentifikasi bahwa pencegahan dan deteksi dini hipertensi dalam kehamilan memerlukan *self-monitoring* tekanan darah berkelanjutan sebagai komponen esensial antenatal care.⁸ Namun, implementasi masih terkendala oleh: (1) ketiadaan teknologi yang mudah diakses dan terjangkau untuk rural/area pesisir; (2) kurangnya integrasi antara monitoring perangkat keras dengan edukasi kesehatan berbasis perilaku untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang.⁹ **Urgensi Penelitian:** Model awal prototipe hibrid ROTASI mengintegrasikan perangkat monitoring fisik (*low-tech*) dan digital berbasis *Health Belief Model* mendukung *self-monitoring* preeklamsia berkelanjutan di wilayah pesisir. Prototipe ini secara signifikan berpotensi dalam pencegahan stunting sektor hulu dan **pencapaian SDG 3.2** (Mengakhiri kematian maternal dan neonatal yang dapat dicegah)¹⁰ serta **Asta Cita 7** (Transformasi SDM berkualitas).¹¹ Prototipe ini bermanfaat untuk mencegah keterlambatan diagnosis preeklamsia, menghindari siklus kelahiran bayi BBLR, dan mendukung program pencegahan stunting di Kota Makassar. **Rumusan Masalah:** Bagaimana mengembangkan dan memvalidasi model awal prototipe hibrid ROTASI, yang mengintegrasikan teknologi monitoring preeklamsia dengan *behavioral intervention* berbasis *Health Belief Model* untuk mendukung *self-monitoring* berkelanjutan dan pencegahan stunting sektor hulu di wilayah pesisir? Penelitian ini difokuskan pada tahap riset dasar dengan tujuan pembuktian konsep pada TKT 2-3. Hasil penelitian ini akan menjadi fondasi untuk penelitian terapan dan hilirisasi pada tahap berikutnya (Tahun 2-5).]

D.2. PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH

Tuliskan pendekatan dan strategi pemecahan masalah yang telah dirumuskan

[Penelitian menggunakan **pendekatan:** *Research & Development (R&D)* dengan kerangka ADDIE (*Analysis-Design-Development-Implementation-Evaluation*) untuk mengembangkan prototipe awal (*low-fidelity*) ROTASI pada TKT 2-3 sebagai pembuktian konsep. Fokus penelitian adalah validasi keamanan, kegunaan, dan kelayakan keberlanjutan melalui integrasi *Health Belief Model* (HBM) dalam desain prototipe fisik dan digital.^{12,13} **Strategi pemecahan masalah:** (1) *Literature review* dan FGD stakeholder (ibu hamil, bidan, kader kesehatan, dan ahli) untuk identifikasi kebutuhan desain dan fitur spesifik; (2) Pengembangan

model awal prototipe hibrid ROTASI terdiri dari komponen digital (aplikasi android) dan fisik (roda putar manual dengan kode warna (Hijau/Kuning/Orange/Merah) untuk melihat status tekanan darah (Normal/Waspada/Bahaya); (3) Validasi ahli dari disiplin berbeda (*obstetric* dan *health education*) menggunakan validasi penilaian *feasibility*, *safety*, *usability*, dan *behavioral alignment*; (4) uji penerimaan pengguna melibatkan 15 ibu hamil di wilayah pesisir Kota Makassar.]

D.3. STATE OF THE ART DAN KEBARUAN

Tuliskan keunggulan dari pemecahan masalah yang ditawarkan pengusul dibandingkan dengan penelitian pengusul sebelumnya atau peneliti lainnya dalam konteks permasalahan yang sama, serta kebaruan usulan dari aspek pendekatan, metode, dsb

[Penelitian preeklamsia sebelumnya fokus pada deteksi klinis melalui antenatal care (ANC) berkala atau pemantauan tekanan darah di rumah menggunakan aplikasi *mobile high-tech* yang sulit diakses di wilayah dengan jaringan terbatas.¹⁴ Kebaruan penelitian ini:

1. Konten prototipe Hibrid ROTASI disusun sepenuhnya berdasarkan *American Heart Association Guideline on Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults 2025*, menetapkan target tekanan darah lebih ketat dan protokol pengukuran mandiri yang spesifik, menjadikan prototipe *self-monitoring* paling mutakhir (*up-to-date*) saat ini.
2. Tahap desain awal penelitian ini dirancang dengan penyelarasan terukur terhadap Asta Cita 7 (SDM Berkualitas) dan SDG 3.2.
3. Prototipe hibrid ROTASI menggabungkan alat ROTASI fisik (roda putar dengan indikator warna sebagai status tekanan darah) dan aplikasi digital ROTASI berbasis android. Pendekatan ini lebih berkelanjutan untuk wilayah pesisir.
4. Penelitian mengintegrasikan *Health Belief Model* secara sistematis dalam desain prototipe *self-monitoring* preeklamsia, memastikan keberlanjutan perilaku jangka panjang bukan hanya monitoring teknis.
5. Pedoman fokus pada hulu pencegahan stunting dengan mengidentifikasi preeklamsia dan mencegah BBLR penyebab stunting. Pencegahan primer ini belum optimal di Indonesia, yang dominan fokus intervensi nutrisi pada anak.]

D.4. PETA JALAN PENELITIAN

Tuliskan peta jalan penelitian dari tahapan yang telah dicapai, tahapan yang akan dilakukan selama jangka waktu penelitian, dan tahapan yang direncanakan.

[Penelitian ini dirancang dengan peta strategis 5 tahun untuk mengembangkan prototipe hibrid ROTASI dari tahap riset dasar hingga hilirisasi. Peta jalan ini selaras dengan SDG 3.2 (target penurunan angka kematian ibu), Asta Cita 7 (mewujudkan transformasi SDM berkualitas), dan prioritas kesehatan nasional (penurunan stunting, penguatan kesehatan ibu).]

PETA JALAN PENELITIAN

TAHAPAN	TAHUN				
	2026	2027	2028	2029	2030
	Riset Dasar & Bukti Konsep	Penelitian Terapan & Pengembangan Model Fidelity	Pengembangan Keberlanjutan & Pengembangan Model Bisnis	Hilirisasi & Komersialisasi	Keberlanjutan & Pemantauan Jangka Panjang
FASE	Analysis-Design-Development-Implementation-Evaluation	Uji efektifitas	Integrasi kebijakan	Hilirisasi & ekspansi	Evaluasi dampak jangka panjang
FOKUS	Validasi ide & pengembangan prototipe <i>low-fidelity</i>	Uji coba <i>multi-site</i> , penyempurnaan berdasarkan masukan pengguna	Mekanisme pengukuran, analisis efektivitas biaya, strategi keberlanjutan	Produksi semi-komersial, pelatihan dalam skala besar, adopsi di berbagai kabupaten	Pemantauan kepatuhan, penilaian dampak, perbaikan berkelanjutan
AKTIVITAS	Studi literatur, desain, produksi prototipe, validasi ahli, uji terbatas (N=15)	Uji lapangan di 3-5 Puskesmas, FGD stakeholder, literasi desain	Analisis biaya implementasi, model keberlanjutan pembangunan, advokasi, sosialisasi awal	Produksi 1000+ unit, training bidan & kader di 15-20 Puskesmas, adopsi resmi Dinas Kesehatan	Pemantauan implementasi jangka panjang, evaluasi dampak pada hasil kesehatan, penyempurnaan versi 2.0
OUTPUT	Prototipe awal, dokumen desain, publikasi konsep, HAKI pendaftaran	Prototipe <i>medium-fidelity</i> , training material untuk bidan, publikasi hasil	Panduan implementasi, laporan efektivitas biaya, perjanjian kemitraan	Unit yang diproduksi secara massal, fasilitator terlatih, adopsi oleh pemerintah daerah.	Laporan evaluasi dampak, rekomendasi perbaikan, prototipe yang diperbarui
TARGET	Produk valid dan praktis, HAKI, serta Publikasi Jurnal Nasional (SINTA 4)	Menunjukkan kelayakan dan efektivitas dalam berbagai konteks	Peta jalan untuk peningkatan dan keberlanjutan	Penerapan dan standarisasi secara luas dalam sistem kesehatan	Memastikan keberlanjutan & efektivitas jangka panjang

E. METODE

Isian metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak lebih dari 1000 kata. Pada bagian metoda wajib dilengkapi dengan:

- Diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG.
- Metode penelitian harus memuat, sekurang-kurangnya proses, luaran, indikator capaian yang ditargetkan, serta anggota tim/mitra yang bertanggung jawab pada setiap tahapan penelitian.
- Metode penelitian harus sejalan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

[Penelitian ini menggunakan **pendekatan** *Research and Development* (R&D) dengan kerangka ADDIE (*Analysis-Design-Development-Implementation-Evaluation*) untuk mengembangkan model awal prototipe hibrid ROTASI pada TKT 2-3. Penelitian difokuskan pada pembuktian konsep bahwa model hibrid yang mengintegrasikan *self-monitoring* fisik (*low-tech*) dan digital berbasis *Health Belief Model* layak digunakan dan diterima oleh pengguna di wilayah pesisir. Desain media ROTASI memuat skala tekanan darah (50-180 mmHg) dan kategori risiko berwarna (Hijau=Normal<120/80, Kuning=Elevated 120-129/<80, Oranye=Stage 1 Hypertension 130-139/80-89, Merah=Stage 2/Crisis $\geq 140/>90$) berdasarkan *AHA guideline* 2025. **Proses** pengembangan model awal prototipe ini akan divalidasi oleh tim ahli multidisiplin dan diuji coba pada 15 ibu hamil. **Indikator** keberhasilan prototipe jika uji kelayakan pada ibu hamil mencapai 80%. Capaian tersebut kemudian menjadi rekomendasi literatif untuk tahap pengembangan lebih lanjut pada penelitian terapan Tahun ke 2-3. Penelitian dilaksanakan selama 12 bulan di wilayah kerja Puskesmas Barombong Kota Makassar. Lokasi penelitian dipilih secara *purposive*, karena tingginya angka risiko preeklamsia dan keterbatasan akses teknologi di wilayah pesisir. Pelaksanaan penelitian melibatkan **kolaborasi tim** multidisiplin antara Dosen Promosi Kesehatan (ketua peneliti), Kesehatan Reproduksi (ahli klinis), dan Teknologi Informatika (pengembang prototipe ROTASI). **Luaran** yang dijanjikan dari penelitian ini adalah model awal prototipe hibrid ROTASI, sertifikat hak kekayaan intelektual (HAKI), dan Artikel ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 4. Alur pelaksanaan penelitian digambarkan secara visual dalam diagram alir penelitian berikut:

Diagram Alir Penelitian



Tabel Tahap Penelitian:

Tahapan & Proses	Luaran & Indikator Capaian	Tim PIC
Tahap 1: Analysis (bulan 1-2) Proses: Studi literatur <i>AHA guideline 2025</i> , survei lapangan (wawancara bidan, kader, & ibu hamil, observasi kendala deteksi dini, pemetaan literasi digital) & Analisis kebutuhan pengguna.	Luaran: Dokumen analisis kebutuhan & data lapangan. Indikator: Tersedia ≥ 10 data wawancara dari stakeholder, <i>AHA guideline 2025</i> , mapping hambatan akses.	Serli (Ketua) & Rasdiana (Anggota)
Tahap 2: Design (Bulan 2-4) Proses: Perancangan model awal prototipe hibrid ROTASI (fisik & digital), penyusunan materi edukasi preeklamsia.	Luaran: <i>Blueprint</i> prototipe hibrid ROTASI & materi edukasi. Indikator: Desain prototipe untuk produksi & materi edukasi sesuai <i>AHA guideline 2025</i> .	Serli (Ketua), Rasdiana (Anggota), & Anggota (St. Mawaddah)
Tahap 3: Development (Bulan 3-7) Proses: Produksi prototipe hibrid ROTASI (fisik dan digital), validasi Ahli, menggunakan instrumen <i>rating scale</i> .	Luaran: Prototipe ROTASI fisik dan digital siap uji & laporan validasi ahli. Indikator: Skor validasi $\geq 75\%$ (skala 100), aplikasi digital berfungsi tanpa error, revisi diterapkan sesuai masukan.	Serli (Ketua), Rasdiana (Anggota), & Anggota (St. Mawaddah)
Tahap 4: Implementation (Bulan 8-10) Proses: Uji coba terbatas dengan 15 ibu hamil risiko tinggi menggunakan prototipe ROTASI (fisik & digital) selama 2 minggu. Pengumpulan data respon pengguna via kuisioner (<i>skala likert</i>) & FGD kelompok kecil.	Luaran: Data pengguna dari 15 ibu hamil, transkripsi FGD, laporan penggunaan model awal prototipe hibrid ROTASI. Indikator: $\geq 80\%$ responden menyatakan prototipe hibrid ROTASI layak digunakan.	Nurfaida & Serli (mahasiswa)
Tahap 5: Evaluation (Bulan 10-12) Proses: Analisis data deskriptif respon pengguna (frekuensi, persentase), sintesis FGD untuk temuan kualitatif, penyusunan laporan akhir komprehensif, pendaftaran HAKI model awal prototipe hibrid ROTASI, submit artikel ke jurnal SINTA 4.	Luaran: Laporan akhir penelitian, sertifikat HAKI (2), artikel ilmiah submitted & penyebaran ringkasan. Indikator: Laporan akhir, HAKI terdaftar di Ditjen HAKI, artikel diterima, laporan tersimpan di perpustakaan.	Semua Tim

Tabel Rencana anggaran Biaya:

No	Tahap	Aktivitas	Alokasi
1	<i>Analysis</i>	Survei, studi literatur, konsultasi stakeholder	Rp 6.000.000 (bahan, konsumsi, dan transport)
2	<i>Design</i>	Workshop desain prototipe, konsultasi ahli, FGD, penyusunan materi	Rp 11.000.000 (sewa ruang, konsumsi, transport, dan honorarium ahli)

3	<i>Development</i>	Produksi fisik & digital prototipe, validasi ahli.	Rp 15.000.000 (Bahan dan <i>finishing</i> prototipe ROTASI fisik dan <i>digital</i>)
4	<i>Implementation</i>	Uji coba model awal prototipe hibrid ROTASI	Rp 11.000.000 (Transport, konsumsi, honor peserta, dan HR)
5	<i>Evaluation</i>	Analisis, publikasi, HAKI, dan laporan.	Rp 6.500.000 (Analisis data, publikasi jurnal, HAKI, laporan akhir, konsumsi, transport dan sewa ruangan)
TOTAL			Rp. 49.500.000

]

F. HASIL YANG DIHARAPKAN

Jelaskan hasil yang diharapkan atau luaran yang dijanjikan dari penelitian

[Luaran yang dijanjikan dari penelitian ini adalah:

1. Model awal prototipe hibrid ROTASI (fisik & digital android aplikasi) tervalidasi
2. Sertifikat hak kekayaan intelektual (HAKI) untuk prototipe hibrid ROTASI (fisik & digital)
3. Artikel ilmiah pada Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 4]

G. JADWAL PENELITIAN

Jadwal penelitian disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian, harap disesuaikan berdasarkan lama tahun pelaksanaan penelitian

[Jadwal penelitian ini dirancang untuk tahun pertama (Tahun 1) penelitian 5 tahunan, fokus pada fase riset dasar dan *proof of concept* TKT 2-3. Ekspansi ke tahun 2-5 akan diajukan dalam proposal lanjutan dengan *scope* penelitian terapan dan hilirisasi.

Tahun ke-1

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Tahap 1: Analysis												
1	Studi literatur (AHA Guideline 2025)	✓											
2	Survei lapangan & analisis kebutuhan	✓	✓										
3	Penyusunan instrumen riset		✓										
B	Tahap 2: Design												
1	Perancangan desain prototipe Fisik			✓	✓								
2	Penyusunan materi edukasi			✓	✓								
3	Perancangan UI/UX prototipe digital aplikasi android				✓								
C	Tahap 3: Development												
1	Produksi prototipe Fisik					✓							
2	Coding & pembuatan aplikasi					✓	✓						

3	Validasi Ahli (media & materi)						✓	✓					
4	Revisi produk							✓					
D	Tahap Implementation 4:												
1	Uji coba terbatas								✓	✓			
2	Pengumpulan data respon pengguna									✓			
E	Tahap 5: Evaluation & Luaran												
1	Analisis data akhir										✓		
2	Penyusunan laporan akhir											✓	✓
3	Pendaftaran HAKI										✓		
4	Submit artikel ilmiah												✓

]

H. DAFTAR PUSTAKA

Sitasi disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

1. [Dewi, KT. 2025. *Prevalence and Associated Factors of Severe Preeclampsia Among Pregnant Women*. *Journal of Bulletin of Inspiring Developments and Achievements in Midwifery (BIDAN)*. Vol. 02, No.1, June 2025, 36-44 e-ISSN: 3089-672X
2. Akbar M, et al. 2025. *The Indonesia pre-eclampsia study (INAPRES): Pregnancy outcomes in pregnancy with pre-eclampsia in Indonesia*. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*. <https://doi.org/10.1002/ijgo.70587>
3. Akbar M, et al. 2025. *Maternal death associated with preeclampsia in Indonesia*. Elsevier, *Pregnancy Hypertension Volume 42*, December 2025, 101400. <https://doi.org/10.1016/j.preghy.2025.101400>
4. Vats H, et al. *Association of Low Birth Weight with the Risk of Childhood Stunting in Low- and Middle-Income Countries: A Systematic Review and Meta-Analysis*. *National Library of Medicine, Pubmed, Neonatology*. 2024;121(2):244-257. DOI: [10.1159/000532006](https://doi.org/10.1159/000532006). Epub 2024 Jan 10.
5. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan RI. SSGI 2024: Hasil Survei Status Gizi Indonesia–Prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8%. Jakarta: Kemenkes RI; 2025.
6. Sarumi N, et al. 2025. *Factor Causes of Stunting in Children in Coastal Areas Health Center Lohia, District Lohia, Muna Regency*. *Journal of Health Science and Pharmacy*. DOI: <https://doi.org/10.36685/jhsp.v2i2.1289>
7. Tucker KL, et al. *Effect of self-monitoring of blood pressure on diagnosis and management of hypertension in pregnancy: The BUMP 1 Randomized Clinical Trial*. *JAMA*. 2022 May 3;327(17):1656–1665. doi: [10.1001/jama.2022.4712](https://doi.org/10.1001/jama.2022.4712)
8. American College of Cardiology/American Heart Association. *New ACC/AHA Guideline on Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults*. Published January 2025. *Volume 151, Number 13* <https://doi.org/10.1161/CIR.000000000000013>
9. Samaran Elisabeth. 2024. *Integration of Digital Health Technologies in Maternal and Child Health Management: Opportunities and Challenges*.

Journal of Social Science Vol.1(4) page 554-566. Published by Global Society Publishing under the terms of the Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

10. United Nations. *The Sustainable Development Goals Report 2025*. <https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2025/2025-updates.pdf>.
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
12. Ajzen I, et al. *The health belief model and the theory of planned behavior: Applied aspects. Chapter in Health Behavior Change: Assessment and Intervention*. Sage Publications; 2015.
13. Mohammadkhah F, et al. 2025. *The effect of training intervention based on health belief model of self-care behaviors in women with gestational diabetes mellitus*. *Frontiers in Global Women's Health. Sec. Maternal Health Volume 5 - 2024*. <https://doi.org/10.3389/fgwh.2024.1490754>
14. Duffy A, et al. 2025. *Examining Challenges to Co-Design Digital Health Interventions With End Users: Systematic Review*. JMIR Publications. *Advancing Digital Health & open science*. Published on 14.Mar. 2025 in [Vol/ 27 \(2025\)](#). [doi:10.2196/50178](https://doi.org/10.2196/50178)